

المثانة الجديدة الأرثوذكسية هي مثانة تُصنع من جزء من أمعائك وتُوصَل بالإحليل (مجرى البول)، فتتبول بالطريقة الطبيعية — دون حقيبة — بعد استئصال المثانة أو عجزها. يتطلب الأمر وقتاً وتدريباً لإتقان التفريغ الكامل واستعادة التحكم.

### عن هذه العملية

يُؤخذ نحو 40-60 سم من الأمعاء الدقيقة ويُعاد طيّه ليشكّل كيساً منخفض الضغط، ثم يُوصَل بالإحليل (مجرى البول)؛ وتُصَبّ الحالبان (أنابيب الكليتين) فيه. لا يوجد فتحة خارجية ولا حقيبة.

لأن المثانة الجديدة من أمعاء، فهي لا تعطي إحساس الرغبة في التبول، لذا تتعلّم:

- التبول وفق جدول زمني — بارخاء قاع الحوض والضغط اللطيف للأسفل — بما يشمل الاستيقاظ ليلاً.
- استخدام القسرة لتفريغها إن لم تفرغ كاملاً (أكثر شيوعاً عند النساء).
- ممارسة تمارين قاع الحوض (كيجل) لتقوية التحكم.

يتحسّن التحكم على مدى أشهر؛ وقد يحدث بعض التسرّب خاصةً ليلاً في البداية. ليس الجميع مؤهلاً — يعتمد ذلك على سلامة الإحليل ووظيفة الكليتين والقدرة على الالتزام بالروتين.

### هل هو آمن؟

هذا خيار ثابت يُعطي أقرب نتيجة "طبيعية". وهو عملية أكبر وأطول من التحويلة الإليالية ويحتاج تعلماً ومتابعة أكثر. المخاطر تشمل: نزيفاً أو عدوى أو تسرباً جراحياً، وتسرب بول نهاري أو ليلي، وعدم اكتمال التفريغ، ومخاط، وعدوى بولية، وتغيّرات طويلة الأمد في الأملاح والفيتامينات تُراقب في المتابعة.

### تعلّم المصطلحات

#### المثانة الجديدة (Neobladder)

مثانة مصنوعة من قطعة أمعاء.

#### أرثوذكسي (Orthotopic)

موضوعة في مكانها الطبيعي وموصولة بالإحليل، فيتمّ التبول بالطريقة المعتادة.

#### الإحليل (Urethra)

الأنبوب الذي يخرج البول من خلاله.

#### الحالبان (Ureters)

أنبوبا الكليتين اللذان يصبّان البول في المثانة الجديدة.

#### التبول الجدولي

التبول في مواعيد محدّدة نهائياً وليلاً دون انتظار الرغبة.

#### القسرة الذاتية

إدخال أنبوب رفيع بنفسك لتفريغ المثانة الجديدة كاملاً عند الحاجة.

#### قاع الحوض

العضلات التي تُدرّب للمساعدة على التحكم في البول.

#### المخاط

مادة تُفرزها الأمعاء بشكل طبيعي؛ خيوطه في البول أمر طبيعي.

هل سيولم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام، فلا تشعر بشيء أثناءها. بعدها، تَوَقَّع ألماً في البطن، وتأخذ الأمعاء أياماً حتى "تستيقظ". ستستيقظ وفي مثانتك الجديدة قسرة (تبقى نحو 3-2 أسابيع) إلى جانب دعامات ناعمة. يبقى معظم المرضى في المستشفى نحو 5-8 أيام، والعملية نفسها طويلة.

### كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

### بعد الجراحة

- تُجرى العملية تحت التخدير العام — اتَّبِع جميع تعليمات الجراحة (الصيام، ووقف مميعات الدم حسب التعليمات). قد تحتاج تحضيراً للأمعاء.
- افهم الالتزام المطلوب: التبول الجدولي نهائياً وليلاً، وربما القسرة الذاتية، وتمارين قاع الحوض.
- امتنع عن التدخين، ورتّب مساعدة في المنزل بعد الخروج.
- أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:
  - تتناول مميع دم، أو لديك عدوى حالية
  - تعاني مرضاً في الأمعاء أو مشاكل في الكلى، أو أجريت عليك جراحة بطنية أو علاج إشعاعي سابق
- تعود إلى المنزل بعد نحو 5-8 أيام مع قسرة لمدة ~3-2 أسابيع؛ قد تُنظفها لإزالة المخاط.
- يُجرى تصوير للمثانة الجديدة للتأكد من الالتئام قبل إزالة القسرة.
- ثم تتعلّم التبول الجدولي (اضبط منبهاً ليلاً)، وتمارين قاع الحوض، والقسرة الذاتية إن لم تفرغ المثانة كاملاً.
- تَوَقَّع تسرباً مبكراً (خاصة ليلاً) يتحسن خلال أشهر. المخاط الطبيعي؛ اشرب السوائل؛ متابعة مدى الحياة (بما فيها vitamin B12).

### ما الذي يحدث أثناء الجراحة

#### اتصل بفريقك الطبي أو اطلب الرعاية إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- عجز عن التبول أو توقّف القسرة عن الصرف
- ألم شديد في البطن أو تقيؤ أو انعدام الغازات والبراز
- نزيف غزير، أو احمرار الجرح أو إفرازاته، أو ألم في الخصرة

1

تكون نائماً تحت التخدير وتُعطى مضادات حيوية.

2

يُعزل جزء من الأمعاء ويُعاد توصيل بقيّتها.

3

يُفتح الجزء المعزول ويُطوى ليشكّل كيساً يُخاط بالإحليل.

4

يُوصل الحالبان بالكيس، وتُوضع قسرة ودعامات ناعمة ريثما يلتئم.

### ثلاثة أمور تذكّرها

1. المثانة الجديدة مصنوعة من أمعاء وموصولة بإحليلك، فتتبول بالطريقة الطبيعية دون حقيبة.
2. تحتاج تدريباً: تبول جدولي نهائياً وليلاً، وتمارين قاع الحوض، وأحياناً قسرة ذاتية. يتحسن التحكم مع الوقت والتسرب المبكر طبيعي.
3. استعدّ بالصيام والتحضير المطلوب والامتناع عن التدخين. أبقِ القسرة حتى يُزيلها فريقك بعد صورة الالتئام، واتصل فوراً إن توقفت عن التبول أو توقفت القسرة عن الصرف.